LAUDO DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

Paciente

Nome: ISAÍAS FARIA
Nascimento: 08/03/1994 (32 anos) | **Sexo:** Masculino | **Documento:** CPF 123.456.789-01
Estado civil: casado | **Profissão:** ENGENHEIRO | **Contato:** (37) 99999-7155

Solicitação

Médico solicitante: ROBERTO MARINHO
Procedimento proposto: SIGTAP 0405050380 - CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA (Eletiva)

Avaliação realizada por

Dr. CARLOS ALBERTO (CARDIOLOGISTA) - CRM/MG 12345

Exame físico

Paciente apresenta IMC 25.9 (Altura 1.79 m, Peso 83 kg), SC 2.03 m2, PA 120 x 80 mmHg, FC 80 bpm, FR 15 irpm, SatO2 99%.

Medicamentos e alergias

Medicamentos em uso: XARELTO (rivaroxabana). **Alergias:** Nenhuma.

Exames complementares

Hemograma: Hb 14,2 g/dL; Coagulograma: INR 1,0; Glicemia: 92 mg/dL; Creatinina: 0,9 mg/dL; Radiografia de tórax: sem alterações agudas; Ecocardiograma: FEVE 62%.

Risco trombótico e de sangramento

Índice de Padua (TEV): Risco alto (4 pontos) - TEV sintomático 11% em 3 meses
Índice IMPROVE (TEV): Risco baixo (0 pontos) - TEV < 1%. **IMPROVE (Sangramento):** Risco baixo - Profilaxia farmacológica possível

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

ACP: Risco intermediário (3%-15%)
ASA: ASA/PS 2 (0.27%-0.4%)
Escala Clínica de Fragilidade: Em forma (CFS 1-3) - 3 pontos (Sem fragilidade)
MELD (hepático): Risco baixo - 6 pontos (Mortalidade 30d ~6-10%)
EMAPO: Muito baixo (<1%)
ARISCAT (pulmonar): Risco baixo - 17 pontos (Complicação pulmonar 1,6%)
VSG-CRI (cirurgia vascular): Risco baixo - 3 pontos (IAM, arritmia ou IC hospitalar: 2.2%)

CONCLUSÃO

Paciente, no momento, em uso de medicação, compensado clinicamente e liberado para a cirurgia proposta.
Recomendações:

- Suspender xarelto (rivaroxabana) antes do procedimento, no prazo indicado para cada medicamento e em acordo com o médico que o prescreveu.
- Realizar profilaxia de tromboembolismo venoso (mecânica e/ou farmacológica) no perioperatório.

As escalas de risco devem ser utilizadas como ferramentas de apoio à decisão clínica e não substituem a avaliação, o julgamento clínico nem a experiência do médico responsável pelo paciente, que são determinantes na conduta final.